



ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემური შედარება-საერთაშორისო გამოცდილება

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-17

თამარ ჩალაძე
სტუ დოქორანტი,
tchaladze@gmail.com

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: **რევაზ შენგელია**
ემდ, სტუ პროფესორი
shengeliarevaz12@gtu.ge

რეზიუმე

წარმოდგენილია ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემების სისტემური შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე. განხილულია ძირითადი მოდელები და მათი რეალიზაცია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში, შვეიცარიაში, ესტონეთში, ლიეტუვაში, ისრაელში, თურქეთსა და მალაიზიაში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საჯარო და კერძო დაფინანსების კომბინაციას, სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის როლს, უნივერსალურ დაფარვას და ფინანსური ხელმისაწვდომობის მექანიზმებს. გაანალიზებულია ჯანდაცვის ხარჯების დონე, დაფინანსების წყაროები და მათი გავლენა ჯანმრთელობის შედეგებზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია საქართველოზე, სადაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ მნიშვნელოვნად გაზარდა სახელმწიფო დაფინანსება და შეამცირა ჯიბიდან გადახდები, თუმცა მოსახლეობის ფინანსური დაცვის გაძლიერება კვლავ გა-
მონევეად რჩება.

საკვანძო სიტყვები: ჯანმრთელობის დაფინანსების სისტემები, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა, ჯიბიდან გადახდები; საერთაშორისო შედარება.

ძირითადი ტექსტი

ბოლო წლებში სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამები ბევრ ქვეყანაში გაფართოვდა და იგი მოსახლეობის აქამდე დაუფარავ ნაწილს ან ახალ სერვისებს მოიცავს. კლასიკურ კვლევაში ესპინგ-ანდერსენმა დასავლური კეთილდღეობის პოლიტიკა სამ მოდელად დაყო: ანგლო-საქსური, ცენტრალური ევროპის და სკანდინავიური. როგორც ანგლო-საქსურ, ასევე სკანდინავიურ მოდელებში სახელმწიფო ცენტრალურ როლს ასრულებს; თუმცა, სკანდინავიურ ქვეყნებს, როგორც წესი, უფრო მაღალი ამბიციები აქვთ, რაც კერძო კომპენსაციებისთვის ნაკლებ ადგილს ტოვებს. ცენტრალური ევროპის მოდელი, პირიქით, მჭიდრო კავშირშია შრომის ბაზართან, სადაც დამსაქმებლები ისტორიულად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებასა და ადმინისტრირებაში. (Molander P, 2025)

ჯანდაცვის მრავალი სისტემა ფოკუსირებულია ჯანმრთელობის უთანასწორობის შემცირებაზე. ამ ძალისხმევამ ახალი მნიშვნელობა მოიპოვა Covid-19-ის პანდემიის შემდეგ, რომელმაც მრავალ ქვეყანაში ჯანმრთელობის უთანასწორობა გაამწვავა. სახელმწიფო ბუნებრივი მარეგულირებელი ორგანოა, თუმცა, უზრუნველყოფისა და დაფინანსების თვალსაზრისით, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლებს შეიძლება განსხვავებული ფორმა ჰქონდეს. ყველა სისტემა არის „ჰიბრიდები“ - არ არსებობს წმინდა საჯარო ან წმინდა კერძო სისტემები, მაგრამ ამ ორი

კომპონენტის შერწყმისა და არჩეული ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით, OECD-ის ქვეყნებმა სხვადასხვა გზა გაიარეს. (Molander P s., 2025)

დიდი ბრიტანეთში ჯანდაცვის სერვისი ძირითადად გადასახადებით ფინანსდება. კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები მოსახლეობის 10.6 პროცენტს აქვს. მათი უმეტესობა კორპორატიული შენატანებია (LaingBuisson 2017). დიდი ბრიტანეთის პრინციპია, რომ ჯანდაცვა ხელმისაწვდომია გაერთიანებული სამეფოს ყველა კანონიერი მაცხოვრებლისთვის.

ესტონეთის ჯანდაცვის სისტემა ფუნქციონირებს სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემის საფუძველზე; ძირითადად, ხელფასის გადასახადით ფინანსდება, დაუზღვეველი ადამიანების უმეტესობა არაფორმალურად ან დროებით დასაქმებულია. ესტონეთის ჯანდაცვის სისტემის სახელმწიფო დაფინანსების დაახლოებით ორი მესამედი სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანებიდან მოდის, რომლებიც 13%-იანი სოციალური ხელფასის გადასახადის მეშვეობით ხორციელდება. სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა მოსახლეობის დაახლოებით 96%-ს ფარავს. თუმცა ამ სქემაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხები სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს იძენს. (WHO, 2023)

ლიეტუვას ჯანდაცვის სამინისტრო და ეროვნული ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდი (NHIF) წარმოადგენენ ძირითად ცენტრალურ ინსტიტუტებს, სადაც ადგილობრივი ადმინისტრაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდებაში. დაზღვევის მისაღებად, ლიეტუვაში მცხოვრებმა პირებმა უნდა შეიტანონ შენატანები NHIF-ში, ბავშვების, სტუდენტების, პენსიონერებისა და უმუშევრების გარდა, რომლებიც გათავისუფლებულნი არიან ამ მოთხოვნისგან და ავტომატურად არიან დაზღვეულნი. NHIF-ის მიერ ლიეტუვის ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა ორ მთავარ პრინციპს ეფუძნება ეფუძნება, ესენია: სოლიდარობა და უნივერსალურობა. (Tran A, 2022). ლიეტუვის ჯანდაცვის სისტემა უნივერსალურია და ძირითადად სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, მომსახურების უმეტეს ნაწილს სახელმწიფო ჯანდაცვის პროვაიდერები ახორციელებენ. (Juodakis J, 2025)

ისრაელი. მსოფლიო ბანკის მიერ მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნად არის კლასიფიცირებული. მისი ჯანდაცვის სისტემა შედგება ეროვნული, დამატებითი და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევისგან. ისრაელში, NHIS-ში არსებული ოთხი ავადმყოფობის ფონდი არის სუბიექტი, რომელიც მართავს როგორც დაფინანსებას, ასევე მათი წევრების ჯანდაცვის უზრუნველყოფას. (Rosen, 2011). სისტემის თავისებურება ის არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე მონაწილეობს ჯანდაცვის უზრუნველყოფაში, როგორც სისტემის მარეგულირებელი ან სპონსორი (Rosen B, 2018). ჯანდაცვის სამინისტრო არეგულირებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდებს მათ მიერ მიღებული კომპენსაციის განსაზღვრით, გარდა ამისა, ის განსაზღვრავს თანაგადახდის ოდენობას, რომლის დაწესებაც ავადმყოფობის ფონდებს შეუძლიათ, და არეგულირებს დამატებითი პაკეტების ფასებსა და შინაარსს (Shmueli A, 2015). ისრაელი, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომლებსაც ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს მსგავსი დონე აქვთ, ჯანდაცვაზე ნაკლებს ხარჯავს. მაგალითად, 2020 წელს მან მშპ-ს 8.3% ჯანდაცვაზე დახარჯა, მაშინ როცა სლოვენია, იაპონია და იტალიამ შესაბამისად 9.5%, 11.1% და 9.5% დახარჯა.

თურქეთის ჯანდაცვის სექტორში დიდი წინსვლა მოხდა 2003 წლიდან, როდესაც მთავრობამ დაიწყო ფართომასშტაბიანი ჯანდაცვის ტრანსფორმაციის პროგრამა (HTP). HTP-მ საბოლოოდ გამოიწვია უნივერსალური ჯანმრთელობის დაზღვევის დაარსება, ხოლო თურქეთის უმრავლესობისთვის გაიხსნა სერვისები და კერძო საავადმყოფოები. პაციენტთა კმაყოფილებისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება სტაბილური იყო, ჩვილებისა და დედების სიკვდილიანობა შემცირდა, ხოლო სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდა. სისტემას აფინანსებენ სახელმწიფო, დამსაქმებლები და დასაქმებულები (Molander P, 2025). თურქეთში კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა გამოიყენება როგორც არასავალდებულო და მეორადი დაზღვევა. ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების წყაროებია დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისგან შეგროვებული პრემიები, ხაზინის დახმარება (გადასახადების მეშვეობით), ფიზიკური პირების მიერ განხორცი-

ელეგული შენატანები და სხვა ჯიბიდან გადახდები და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის პრემიები (Guduk o, 2020).

მაღალიზიის ჯანდაცვის სისტემა მოიცავს საჯარო და კერძო ჯანდაცვის ნაზავს, ჯანდაცვის სამინისტრო სხვადასხვა ჯანდაცვის დაწესებულების მეშვეობით სთავაზობს პირველად, მეორად და მესამეულ ჯანდაცვის მომსახურებას, კერძო ჯანდაცვის პროვაიდერები ავსებენ საჯარო ჯანდაცვის მომსახურებას. ჯანმო-მ მაღალიზიის ჯანდაცვის სისტემას მაღალი შეფასება მისცა, როგორც „დაბალი ღირებულების ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსალურ და ყოვლისმომცველ მომსახურებას“. ზოგიერთი ჯანდაცვის ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ მაღალიზია UHC მიაღწია 1980-იან წლებში, რაც ძირითადად ვლინდება ისეთ მაჩვენებლებში, როგორიცაა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. (William D, 2011)

გერმანიას მსოფლიოში უძველესი სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა აქვს. ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულოა, მაგრამ ადამიანებს, რომელთა შემოსავალი ფიქსირებულ ზღვარს აჭარბებს ან კონკრეტულ პროფესიულ ჯგუფს მიეკუთვნებიან (მაგ., თვითდასაქმებულები ან საჯარო მოხელეები), შეუძლიათ უარი თქვან სახელმწიფო დაზღვევაზე და კერძო (შემცველ) ჯანმრთელობის დაზღვევაში დარეგისტრირდნენ. მოსახლეობის დაახლოებით 11% დაფარულია კერძო დაზღვევით; 89% - სსდ. მიუხედავად იმისა, რომ დაფარვა უნივერსალურია ყველა კანონიერი მაცხოვრებლისთვის და მოსახლეობის მხოლოდ 0.1%-ს არ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა, ფინანსური ან ადმინისტრაციული ბარიერების გამო ჯერ კიდევ არსებობს. მრავალგადამხდელიანი სოციალური დაზღვევის დაფინანსება მოიცავს ჯანმრთელობის (57%), პენსიის (10%), გრძელვადიანი მოვლის (2%) და სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევის (1%) დაზღვევას. (Askarzade E, 2024).

2020 წელს შვეიცარია ევროპაში ყველაზე დიდი ხარჯვის მქონე ქვეყანა იყო, ერთ სულ მოსახლეზე 4997 ევრო დახარჯა, შემდეგ მოდიოდა გერმანია 4831 ევროთი. ნიდერლანდებში, ავსტრიაში და შვედეთში ხარჯების დონე ასევე გაცილებით მაღალი იყო ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელზე. (Petre I, 2023)

ნიდერლანდებში ეროვნული ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა პირველად 1941 წელს ამოქმედდა, რაც ასახავდა სახელმწიფო და კერძო ჯანდაცვის დამზღვევების გერმანულ ბისმარკის მოდელს. მოსახლეობის დაახლოებით 63 პროცენტი დაფარული იყო სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაზღვევით, ხოლო უფრო შეძლებულ ფენებს შეეძლოთ კერძო დაზღვევის არჩევა ან დაუზღვეველად დარჩენა. ნიდერლანდებმა 2021 წელს ჯანდაცვაზე მშპ-ს 11.3% დახარჯეს ერთ სულ მოსახლეზე, ეს 7179 აშშ დოლარის ეკვივალენტური იყო, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროკავშირისა და ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში. (Tikkanen R, 2020)

შვეიცარიას ჯანდაცვის განსაკუთრებით მაღალი სტანდარტი აქვს. კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულოა შვეიცარიაში მცხოვრები ყველა მოსახლისთვის. ბენეფიციარი ძირითადი დაზღვევის ღირებულებაში პირადი შემოსავლის 8%-მდე იხდის. თუ პრემია შემოსავლის 8%-ზე მეტს შეადგენს, მთავრობა სხვაობის დასაფარად ფულად სუბსიდიას გასცემს. შვეიცარიას მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კერძო ჯანდაცვის სექტორი აქვს. ეს პაციენტებისთვის სასარგებლოა, რადგან კონკურენცია დიდ არჩევანს ქმნის. ბენეფიციარს აქვს უფლება შეცვალოს სადაზღვევო კომპანია წელიწადში ერთხელ.

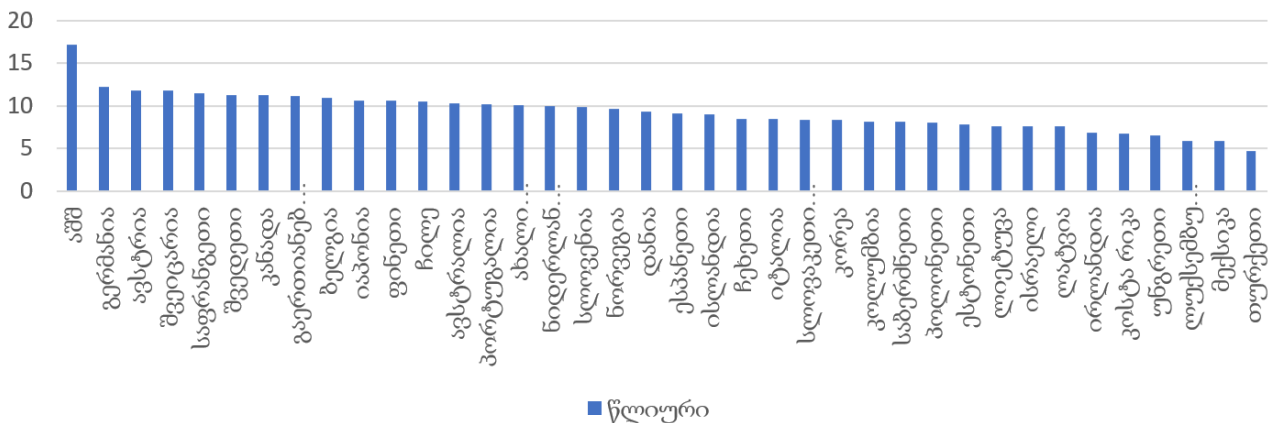
ბოლო 70 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სექტორი სწრაფად გაიზარდა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჯანდაცვა მთლიანი შიდა პროდუქტის მშპ-ს 17%-ზე მეტია (Gruber 2022)

2021 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დახარჯა მნიშვნელოვნად მეტი, ვიდრე ნებისმიერმა სხვა ქვეყანამ (12 555 აშშ დოლარი ერთ ადამიანზე) და ასევე დახარჯა ყველაზე მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის წილის გაზომვისას. ჯანმრთელობის დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე ასევე შედარებით მაღალი იყო შვეიცარიაში, გერმანიაში, ნორვეგიაში, ნიდერლანდებსა და ავსტ-

რიაში. მექსიკამ, კოლუმბიამ, კოსტა-რიკამ და თურქეთმა დახარჯეს ყველაზე ცოტა - ერთ სულ მოსახლეზე 2000 აშშ დოლარზე ნაკლები. მიუხედავად იმისა, რომ გასული ათწლეულის განმავლობაში ჯანდაცვის ხარჯები, როგორც წესი, გაიზარდა უფრო სწრაფად, ვიდრე მშპ, პანდემიის შემდეგ უმეტეს ქვეყნებში მისი წილი მთლიან ეკონომიკაში დაეცა.

ევროპის 34 ქვეყანაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების მუშაობის განმსაზღვრელი ფაქტორების საშუალო მნიშვნელობებით შეიძლება აღინიშნოს, რომ სიცოცხლის უფრო მაღალი ხანგრძლივობა დამახასიათებელია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ უფრო მაღალი კეთილდღეობა, ეკონომიკური განვითარება და სოციალური უსაფრთხოება. კერძოდ, ყველაზე მაღალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შვეიცარიაშია (82.19 წელი). ამავდროულად, ნამყვანი ქვეყნების ჯგუფში ასევე შედიან ისლანდია, იტალია, ესპანეთი, შვედეთი, საფრანგეთი და ნორვეგია, სადაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 81 წელია. კიდევ 7 მაღალგანვითარებულ ქვეყანას დაახლოებით 80 წელი აქვს სიცოცხლის ტიპური ხანგრძლივობა, ხოლო კიდევ 4-ს - დაახლოებით 79 წელი. პირიქით, საშუალოზე დაბალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამახასიათებელია ეკონომიკური ზრდის შედარებით დაბალი ტემპის მქონე ქვეყნებისთვის. (Kwilinski A, 2024)

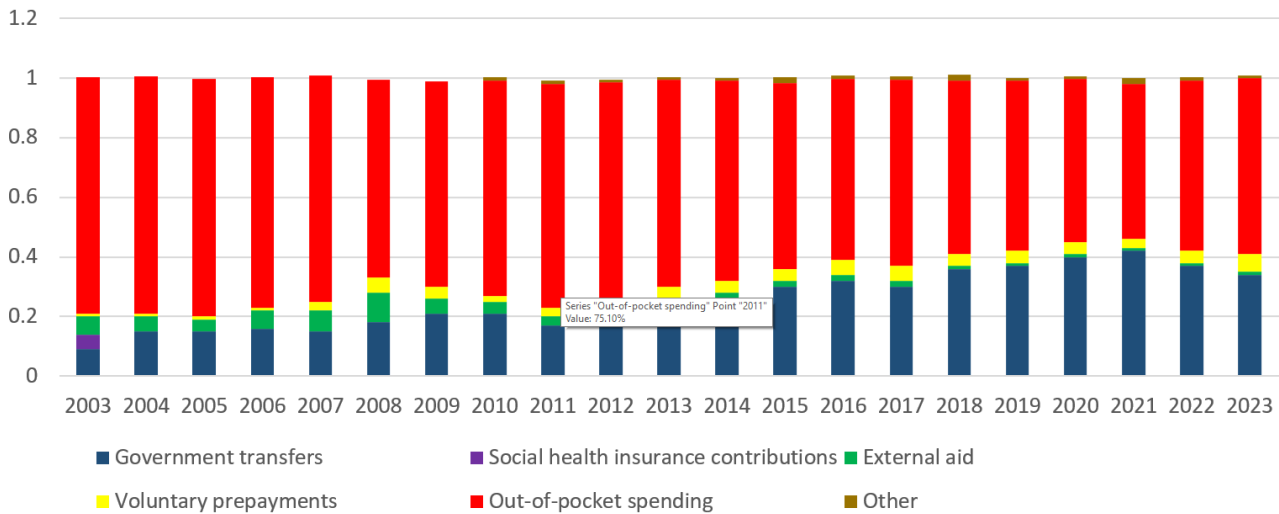
2024 წ. ჯანდაცვის ხარჯი მშპ %



<https://www.oecd.org/en/data/indicators/health-spending.html>

საქართველოში 2013 წლიდან ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც დაზღვეულია მოსახლეობის 90%, ხოლო კერძო დაზღვევით სარგებლობს დაახლოებით 9%, დაუზღვეველი 1%-ს წარმოადგენს. საქართველოში ჯანდაცვაზე დანახარჯები შეადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაახლოებით 10%-ს და მთლიანი შიდა პროდუქტის 3-3,2%-ს, მაშინ, როდესაც ევროპის განვითარებული ქვეყნები ხარჯავდნენ 7-9%-ს, ხოლო აშშ-15%-ს. ჯანდაცვის სექტორისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო ასიგნებების მოცულობა 11 წლის განმავლობაში 2024 წელს, 2013 წელთან შედარებით, 3.6-ჯერ გაიზარდა. მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი 88 მილიონიდან 1346 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდების წილი კი 2012 წლის 73.4%-დან 2024 წელს შემცირდა 41%-მდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს განვითარებული, თუ განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობაში, მშპ-დან შემოსავლების ხვედრითი წილი ჩამორჩება დანახარჯებს. თუ სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტია ქვეყანაში, ანუ როდესაც სახელმწიფო ხარჯები აღემატება შემოსავალს, ძნელია სახელმწიფო ხარჯების გაზრდა ჯანმრთელობის ან სხვა სექტორებზე.

ჯანდაცვის დანახარჯები საქართველო



https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიხედვით, ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები უნდა შეადგენდეს მთლიანი ხარჯების 40%-ზე მეტს. თუ ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი ნაკლებია, მაშინ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის სექტორში შეზღუდულია. საქართველოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 74,1 შეადგენს; 2023 წლის მონაცემებით, სახელმწიფო ჯანდაცვის ხარჯების წილი მთლიან სახელმწიფო ხარჯებში 7,8% შეადგენს (WHO, 2023).

უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სისტემაში გატარებული რეფორმების შედეგად საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასიგნება, თუმცა კვლავ მაღალია შინამეურნეობათა მიერ სამედიცინო მომსახურებაზე დანახარჯების შედეგად გაღარიბების რისკი. სწორედ ჯიბიდან გადახდების მაღალი წილი წამოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ძირითად პრობლემას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Askarzade E, G. H. (2024). The Role of Supplementary Insurance in Achieving Universal Health Coverage: A Comprehensive Review . *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 2024.
2. Guduk o, T. M. (2020). EXAMINATION OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN TERMS OF HEALTH SERVICES USAGE IN TURKEY . *Int Journal Of Health Manag. And Tourism* .
3. Juodakis J, Z. S. (2025). Data Resource Profile: The Lithuanian health data. *International Journal of Epidemiology*.
4. Kwilinski A, V. A. (2024). Efficiency of Healthcare Financing: Case of European Countries. *International Journal of Financial Studies*.
5. Molander P. (2025). *The European Journal of Health Economics* .
6. Molander P, s. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
7. Molander1 P. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
8. OECD. (2023). European Observatory on Health Systems and Policies.
9. Petre I, B. F. (2023). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. *Healthcare*.
10. Rosen B, W. R. (2018). Advancing Universal Health Coverage: What Developing Countries Can Learn from the Israeli Experience?.

11. Shmueli A, S. P. (2015). Managed care in four managed competition OECD health systems. *Health Policy*.
12. Tikkanen R, O. R. (2020). International profiles of health care systems.
13. Tran A, S. R. (2022). The temporal trend of cause-specific. *Tran et al. BMC Public Health*.
14. WHO. (2023). მოპოვებული https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en-დან
15. WHO. (2023). <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/estonia-health-system-review-2023>.
16. William D, S. a. (2011). Achieving universal health coverage: learning from Chile, Japan, Malaysia and Sweden. *Results for Development Institute*.
17. ვერულავა თ. (2020). ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტი.
18. მენაბდე ე, ლ. კ. (2017). ჯანდაცვის ეკონომიკის თანამედროვე მოდელები. ბიზნეს ინჟინერინგი.
19. ჭიოტაშვილი დ, ჩ. ხ. (2024). სადაზღვევო ბაზრის განვითარების დინამიკა, გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოში. ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრირება.

REFERENCES:

1. Askarzade E, G. H. (2024). The Role of Supplementary Insurance in Achieving Universal Health Coverage: A Comprehensive Review . *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2024*.
2. Guduk o, T. M. (2020). EXAMINATION OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN TERMS OF HEALTH SERVICES USAGE IN TURKEY . *Int Journal Of Health Manag. And Tourism* .
3. Juodakis J, Z. S. (2025). Data Resource Profile: The Lithuanian health data. *International Journal of Epidemiology*.
4. Kwilinski A, V. A. (2024). Efficiency of Healthcare Financing: Case of European Countries. *International Journal of Financial Studies*.
5. Molander P. (2025). *The European Journal of Health Economics* .
6. Molander P, s. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
7. Molander1 P. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
8. OECD. (2023). European Observatory on Health Systems and Policies.
9. Petre I, B. F. (2023). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. *Healthcare*.
10. Rosen B, W. R. (2018). Advancing Universal Health Coverage: What Developing Countries Can Learn from the Israeli Experience? .
11. Shmueli A, S. P. (2015). Managed care in four managed competition OECD health systems. *Health Policy*.
12. Tikkanen R, O. R. (2020). International profiles of health care systems.
13. Tran A, S. R. (2022). The temporal trend of cause-specific. *Tran et al. BMC Public Health*.
14. WHO. (2023). მოპოვებული https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en-დან
15. WHO. (2023). <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/estonia-health-system-review-2023>.
16. William D, S. a. (2011). Achieving universal health coverage: learning from Chile, Japan, Malaysia and Sweden. *Results for Development Institute*.
17. Verulava T. (2020). Healthcare Cost Containment Mechanisms and the Georgian Healthcare System. Information Development Institute.
18. Menabde E, L. Q. (2017). Modern Models of Health Economics. Business Engineering.
19. Chiotashvili D, Ch. Kh. (2024). Dynamics of Insurance Market Development, Challenges and Opportunities in Georgia. Economics, Business and Administration. <https://www.geostat.ge/ka>

SYSTEMIC COMPARISON OF HEALTH CARE FINANCING: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Tamar Chaladze

PhD student of GTU
tchaladze@gmail.com

Scientific Supervisor: **Revaz Shengelia**,

PhD, Professor of GTU
shengeliarevaz12@gtu.ge

RESUME

The article presents a systemic comparative analysis of health care financing systems based on international experience. It examines the main financing models and their implementation in different countries, including the United Kingdom, Germany, the Netherlands, Switzerland, Estonia, Lithuania, Israel, Turkey, and Malaysia. Particular attention is paid to the combination of public and private financing, the role of social health insurance, universal coverage, and mechanisms ensuring financial accessibility. The study analyzes levels of health care expenditure, sources of financing, and their impact on health outcomes. Special emphasis is placed on Georgia, where the Universal Health Care Program has significantly increased public funding and reduced out-of-pocket payments; however, strengthening financial protection for the population remains an ongoing challenge.

Key words: Health financing systems, Universal health coverage, Out-of-pocket payments, International comparison.